

による嚔声のメカニズムには、声帯血腫（coumadin, 血栓溶解薬, PDE-5 阻害薬）、化学的喉頭炎（ビスホスホネート薬）、咳（ACE 阻害薬）、粘膜の乾燥（抗ヒスタミン薬、利尿薬、抗コリン薬）、喉頭ジストニア（定型/非定型抗精神病薬）、性ホルモン産生・利用の変化（danocrine, testosterone）などがある²⁾。

診断

a 問診

症状発現の時期、嚔声の状態（かすれ、つまり、高音が出ない、苦しいなど）、症状発現の契機と経過（上気道炎後、音声酷使、外傷、心理的ストレスなど）、随伴症状（胃酸逆流症、嚥下障害・構音障害など）、既往歴（脳、頸部、胸部の手術歴など）、生活歴（喫煙、飲酒など）、社会生活習慣（声を生業にする歌手・教師などの職業歴、スポーツやカラオケなど声にかかわる趣味など）、服薬の内容（ICS など）などを聴取する³⁾。

b 身体所見、一般的検査

頸部所見を含む全身の身体所見をもれなく観察する。病歴と身体所見から原因疾患が推定できることも多い。声の質も確認をする。頸部腫瘍、リンパ節触知、聴診での wheezes, stridors も重要な所見である。声帯麻痺を疑うときは、内視鏡で声帯の状態を観察する。胸部疾患を疑うときは、胸部 X 線検査を行うが、それ以外は声帯麻痺の確認後に行う。

c 耳鼻咽喉科専門医へ紹介するタイミング

急性喉頭蓋炎、喉頭浮腫、両側反回神経麻痺など嚔声とともに呼吸困難を伴う疾患は緊急の対応が必要であることを念頭におく必要がある。至急に専門医へ紹介し、呼吸困難が進行するようなら挿管ないしは気管切開を考慮する。

それ以外でも 2~4 週間以上症状が持続する場合や時期にかかわらず留意すべき徴候（頸部腫瘍、stridor の聴取、重喫煙歴、前頸部・脳神経または胸部手術の既往、最近の挿管歴、原因不明の体重減少、嚥下障害・構音障害などの神経障害を伴うなど）を認めた場合は速やかに耳鼻咽喉科専門医へ紹介するべきである²⁾。

治療、処置

治療は原疾患によるため、耳鼻咽喉科医や脳神経内科医によることが多い。急性発症例の多くは自然寛解

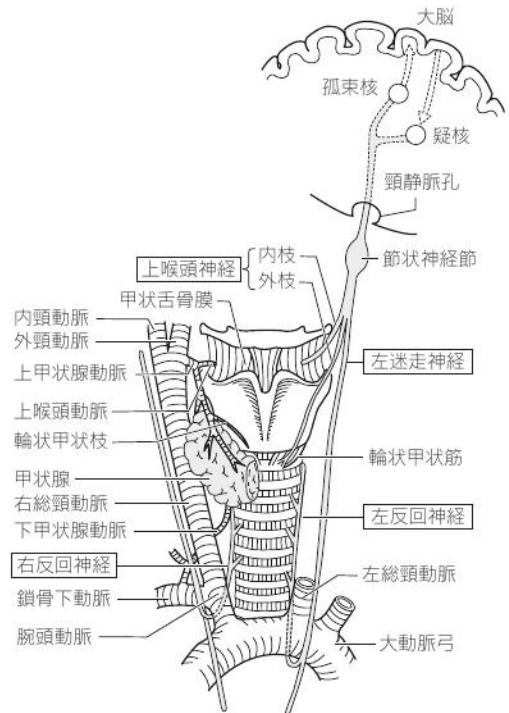


図1 喉頭の神経・血管

[喜多村健ほか（編）：NEW 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学，第2版，南江堂，p202，2007より引用]

するが、声の衛生（加湿および水分摂取の励行、刺激物の吸入・摂食を避ける、頻回の咳をしない、長期間大声を出さない、大食やアルコール多飲・喫煙を避けるなど）の指導が必要である。ICSが原因の場合は、うがいの徹底を指導し、ICS用量の減量、吸入薬の変更などを検討する。喉頭内視鏡検査で声帯麻痺と診断された場合は、CT・MRIなどの検査を行い、原疾患の診断、治療を行う。

文献

- 1) Schwartz SR, et al : Otolaryngol Head Neck Surg **141** : S1, 2009
- 2) Stachler RJ, et al : Otolaryngol Head Neck Surg **158** : S1, 2018
- 3) 日本音声言語医学会・日本喉頭科学会（編）：音声障害診療ガイドライン 2018 年版，金原出版，2018
- 4) House SA, et al : Am Fam Physician **96** : 720, 2017
- 5) 久 育男：喉頭の構造の機能。NEW 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学，第2版，喜多村健ほか（編），南江堂，p202-205, 2007